

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN EARLY HPP		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	129.34/I-SPO/MTR/II/2026	01	1 / 4
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 18 Februari 2026	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Istantini, M.kes	
Pengertian	Penatalaksanaan yang dilakukan pada ibu post partum yang mengalami perdarahan lebih dari sama dengan ≥ 500 cc dalam satu menit dan atau disertai uterus yang tidak berkontraksi dalam 15 detik setelah placenta lahir.		
Tujuan	1. Sebagai acuan penerapan penatalaksanaan <i>early HPP</i> 2. Menghentikan perdarahan yang berlebihan pada ibu post partum 3. Menjaga kondisi ibu post partum dalam kondisi stabil dan tidak jatuh dalam keadaan <i>late HPP</i> 4. Agar tindakan yang dilakukan berjalan efektif, efisien, konsisten dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman PONEK 24 jam 2. Dilakukan oleh Dokter dan Bidan.		
Prosedur	1. Siapkan alat 1) Siapkan alat-alat: a. Sarung tangan steril b. Obat-obatan (metergin, cairan infus RL/NS 0,9%, oksitosin) c. Foley kateter d. Infus set e. Bethadine f. Kassa g. Bengkok h. APD (Celemek, masker, google, sepatu boot) i. Oxyflo/ Hi-oxy 2) Dekatkan alat disamping pasien 2. Siapkan pasien a. Lakukan tindakan dengan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) b. Perkenalkan diri pada pasien c. Identifikasi pasien (nama , register , tanggal lahir) d. Jelaskan pada ibu tujuan dan prosedur yang akan dilakukan e. Atur pasien dalam posisi dorsal recumbent		
Prosedur	1. Siapkan lingkungan 2. Pasang sampiran/ sketsel 3. Lakukan penatalaksanaan early HPP		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN EARLY HPP		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	129.34/I-SPO/MTR/II/2026	01	2 / 4
	ATONIA UTERI - Cuci tangan 6 langkah - Pakai APD sesuai standar (Celemek, masker, google, sepatu boot dan sarung tangan) - Bersihkan bekuan darah dan atau selaput ketuban dari vagina dan lubang servik - Pastikan kandung kemih kosong, jika perlu lakukan kateterisasi - Lakukan kompresi bimanual interna (KBI) selama 5 menit - Masukkan tangan secara obstetrik melalui introitus vagina - Kepalkan tangan dalam dan tempatkan pada forniks anterior, tekan dinding anterior uterus ke arah luar yang menahan dan mendorong dinding posterior uterus ke arah depan sehingga uterus ditekan dari arah depan dan belakang. - Tekan kuat uterus diantara kedua tangan. - Suntikkan methergin 0,2 mg IM (kontra indikasi pada pasien hipertensi) - Pasang infus dengan cairan RL drip oksitocin 20 iu dengan tetesan 60 tetes permenit - Selama melakukan suntikan methergin dan infus , lakukan kompresi bimanual eksterna (KBE) - Letakkan satu tangan pada dinding abdomen dan dinding depan korpus uteri dan di atas simfisis. - Letakkan tangan lain pada dinding abdomen dan dinding belakang korpus uteri sejajar dengan dinding depan korpus uteri. Usahakan untuk mencakup/memegang bagian belakang uterus seluas mungkin. - Lakukan kompresi uterus dengan cara saling mendekatkan tangan depan dan belakang agar pembuluh darah di dalam anyaman miometrium dapat dijepit secara manual. - Pastikan kontraksi uterus baik. - Lanjutkan infus dengan cairan RL drip oksitocin 20 iu dengan tetesan 40 tetes permenit - Pasang kondom kateter (jika uterus belum kontraksi maksimal)		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN EARLY HPP		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	129.34/I-SPO/MTR/II/2026	01	3 / 4
	15. Permintaan Labu darah kondisi emergency (sesuai advice DPJP operator atau anestesi) a) Unit menghubungi petugas laboratorium meminta persediaan labu darah golongan O minimal 5 labu b) Keputusan uncrossmatch dipilih oleh operator anestesi dengan segala risiko yang terjadi dan sudah dijelaskan kepada keluarga c) Jika keluarga bersedia dengan risiko pemberian labu darah uncrossmatch, pastikan sudah ada tanda tangan di informed consent d) Unit yang meminta melakukan penginputan labu darah di SIMRS e) Petugas Laboratorium menyiapkan labu darah golongan darah O minimal 5 labu tanpa pengecekan golongan darah dan <i>uncrossmatch</i> f) Petugas laboratorium membuat permintaan labu darah golongan O minimal 5 labu lagi ke PMI cito tanpa pengecekan golongan darah dan <i>uncrossmatch</i>		
Prosedur	RETENSIO PLACENTA 1. Cuci tangan 6 langkah 2. Pakai APD sesuai standart (Celemek, masker, google, sepatu boot dan sarung tangan) 3. Pastikan kandung kemih dalam keadaan kosong, lakukan kateterisasi bila perlu 4. Pasang infus dengan cairan RL drip oksitocin 20 iu dengan tetesan 20 tetes permenit 5. Tangan kiri untuk menahan fundus uteri 6. Sambil menahan fundus uteri , masukkan tangan dalam hingga ke kavum uteri sehingga mencapai tempat implantasi placenta 7. Bentangkan Masukkan tangan secara obstetrik dengan menelusuri sisi bawah tali pusat 8. Saat mencapai bukaan servik, minta asisten untuk memegangkan klem tali pusat kemudian pindahkan tangan obstetri menjadi datar seperti memberi salam (ibu jari merapat ke jari telunjuk dan jari jari lain saling merapat) 9. Tentukan implantasi placenta, temukan tepi placenta paling bawah 10. Setelah ujung ujung jari masuk di antara placenta dan dinding uterus maka perluas pelepasan placenta dengan jalan menggeser tangan ke		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN EARLY HPP		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	129.34/I-SPO/MTR/II/2026	01	4 / 4
	kanan dan ke kiri sambil digeserkan ke atas hingga semua perlekatan placenta terlepas dari dinding uterus. 11. Sementara satu tangan masih di dalam kavum uteri , lakukan eksplorasi untuk menilai tidak ada sisa placenta yang tertinggal. 12. Pindahkan tangan luar dari fundus ke supra simfisis kemudian instruksikan asisten untuk menarik tali pusat sambil tangan dalam membawa placenta keluar 13. Lakukan penekanan uterus ke arah dorso kranial setelah placenta dilahirkan dan tempatkan placenta di dalam wadah yang telah disediakan 14. Pastikan kontraksi uterus baik 3. Rapihan pasien dan bereskan alat a. Rapihan pasien dengan posisi yang nyaman b. Cuci tangan 6 langkah c. Lakukan evaluasi dan dokumentasi perkembangan pasien d. Periksa kembali tanda vital ibu e. Beritahu ibu bahwa tindakan sudah selesai dilakukan tap ibu masih perlu pemantauan hingga 2 jam sebelum dipindahkan ke ruang nifas f. Catat kondisi ibu dan buat laporan tindakan		
Unit Terkait	1. Maternitas 2. IGD PONEK 3. <i>Recovery Room</i>		